

SEDACIÓN PALIATIVA EN URGENCIAS

Silvia García Martínez, Álvaro González de Diego, Valentin Riaño Zalbidea

SITUACIONES CLÍNICAS EN EL FINAL DE LA VIDA

- Enfermedad INCURABLE AVANZADA
- Enfermedad TERMINAL
- AGONÍA

Enfermedad TERMINAL:

- Paciente oncológico:
 - Enfermedad oncológica avanzada, progresiva e incurable, con histología demostrada (según situación clínica).
 - Respuesta mínima o nula a tratamiento activo.
 - Sintomatología múltiple, intensa, multifactorial y cambiante.
 - Palliative Performance Status (PPS) <40 (funcionalidad).
 - Impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico, en relación a la muerte.
 - Pronóstico vital: Limitado.
- Paciente NO oncológico (National Hospice Organization):
 - Enfermedad en progresión (clínica, exploraciones complementarias).
 - Varias consultas o ingresos en últimos 6 meses deterioro funcional (Karnofsky ≤ 50) o dependencia para ≥ 3 ABVD.
 - Desnutrición (pérdida ponderal $>10\%$ en últimos 6 meses o albúmina $<2.5\text{g/dl}$).
 - Factores pronósticos y criterios de terminalidad, según patología (tabla2).

SEDACIÓN

Definición

Persigue controlar un síntoma físico o psíquico, refractario al tratamiento, con el objetivo deliberado de disminuir el nivel de consciencia, para aliviar el sufrimiento, habitualmente en fase de agonía. No busca acelerar el proceso.

Aspectos éticos

- Principio de autonomía: ¿Qué desea el paciente? Preguntar al paciente, a la familia, o atender al documento de voluntades anticipadas (DVA) si lo hubiera.
- Principio de beneficencia: El objetivo es aliviar el sufrimiento. Buscar el nivel de sedación para un buen control sintomático, a las mínimas dosis posibles.
- Debe existir ≥ 1 síntoma refractario a múltiples tratamientos en tiempo razonable.
- Reflejar todo el proceso en la historia clínica.

Preparación

- Ambiente: tranquilo y privado. Evitar movilizaciones, curas... innecesarias.
- Actitud: Comprensión, empatía, disponibilidad, compañía, al paciente y familia.
- Familia: Información clara y veraz. Resolver dudas y juicios de valor erróneos.
- Reevaluar: Nivel de sedación y confort del paciente, estado emocional de familia.

Tratamiento farmacológico

- ¿Qué hacemos con su tratamiento habitual? Adecuar secuencialmente el esfuerzo terapéutico (ASET). Mantenemos aquellos fármacos con intención sintomática.

- Tener en cuenta el tratamiento analgésico y el neuropsiquiátrico previo, de cara a administrar una dosis total diaria adecuada (evitando una sedación inefectiva).
- Niveles de sedación:

Escala de Ramsay	
• I • II • III • IV • V • VI	• Agitado y angustiado. • Tranquilo, orientado y colaborador. • Respuesta a estímulos verbales. • Respuesta rápida a estímulos dolorosos. • Respuesta perezosa a estímulos dolorosos. • Sin respuesta.
IC	E. Pulmonar
• NYHA IV • FEV1≤20% • Clínica a pesar de tto médico óptimo. • IC refractaria + arritmias	• Grave: a. Disnea reposo, sin respuesta a BD y ↓ capacidad funcional. b. Progresión: ↑ hospitalización/ visitas médicas. ↓ FEV1>40ml/año. • Hipoxemia (PaO₂ <55mmHg o sat<88%) o Hipercapnia (PaCO₂ > 50) (en últimos 3 meses). • IC derecha o cor pulmonale (no secundario a IC izq ni valvulopatía) • FC reposo >100lpm
Cirrosis hepática	Insuficiencia Renal Terminal
• Child-Pugh C (12-15) no candidato a transplante. • EEmpeoran pronóstico: . IP<30% + Alb <2.5g/dl. . Ascitis refractaria*. PBE**. Síndrome hepatorenal**. Encefalopatía hepática refractaria*. Sangrado por varices recurrente, a pesar de tratamiento. . Malnutrición ↑, ↓ masa muscular, enolismo activo. Carcinoma hepatocelular. HBsAG +	• FG <15ml/min; rechazo, desestimación o futilidad de diálisis o transplante. • Clínica de Uremia (confusión, náuseas, vómitos refractarios, prurito). • Diuresis < 400ml/día. • Hipercalcemia >7mEq/l, refractaria. • Pericarditis urémica, síndrome hepatorenal o sobrecarga de flúidos intratable.
Coma y estado vegetativo	Ictus y demencias
• Condición clínica de inconsciencia completa de sí mismo y del entorno que le rodea, acompañándose de ciclos de ojos abiertos-cerrados, con completo o parcial mantenimiento de las funciones autónomas cerebrales.	• GDS-FAST 7c*** • En último año: Neumonía aspirativa, pielonefritis, UPPs estadio 3-4, fiebre recurrente tras antibiótico, disfagia o negativa a la ingesta.
E. Parkinson	ELA
• Hoehn y Yahr estadio 5 (= Caquexia, invalidez, imposibilidad para bipedestación o deambulación, cuidado constante de otra persona)	• Poliulcerados. • Deterioro funcional grave (Barthel < 20, Katz F/G****).
VIH y SIDA	
• CD4<25 cél/mm² • Carga viral >100.000col/ml • Karnofsky <50*****	

Criterios de terminalidad según patología de base.

*Ascitis refractaria a restricción de sodio y a diurético. Encefalopatía refractaria a lactulosa, neomicina y restricción proteica.

** PBE supervivencia al año 30%. SHR pronóstico de días o semanas.

***GDS-FAST= Global Deterioration Scale - Functional Assessment Staging. 7= Deterioro cognitivo muy severo. C= No camina sin ayuda.

****KATZ =Índice de independencia. F=Ayuda para aseo, wc, movilidad. G= Ayuda para seis funciones (F+alimentación o continencia).

*****Karnofsky= Escala funcional. <50: Requiere gran atención, incluso médica (o peor).

Principales fármacos empleados:

- Benzodiazepinas (BZD): Midazolam.
- Neuroléptico (NLP): Levomepromazina (sc).
- Barbitúricos (B): Fenobarbital (sc).
- Anestésicos (AN): Propofol (infusión continua) (sólo en hospital).

FÁRMACO	PRESENTACIONES	POSOLÓGÍA	
		SC	IV
MIDAZOLAM (MDZ) (Dormicum®): • ¡1ª ELECCIÓN! • SEDANTE BZD hidrosoluble de acción corta. • Inicio acción 5-10'(sc) y 2-3'(iv). • Tiempo hasta efecto máx. 30-60'. • Vida media 2-5h. • Dosis max. (sc, iv): 160-200mg/día (riesgo de agitación paradójica). • Metabolismo hepático. Eliminación renal.	• MDZ 1mg/ml amp 5ml (1 amp=5mg). • MDZ 5mg/ml amp 1ml (1 amp=5mg). • MDZ 5mg/ml amp 3ml (1 amp=15mg). • MDZ 5mg/ml amp 10ml (1amp=50mg).	• ¡1ª elección y más en DOMICILIO! • DI: Para Ramsay II-III. De 2,5mg-5mg(bolos) y 0,4-0,8mg/h (pc). Según situación clínica, edad, BZD o NLP previos, enolismo o tóxicos, hasta 5-10mg (bolos) y 1-2mg/h (pc). • DTD: DI x6. • SC bolos: Repartir en 4 tomas. • SC pc. • DR: = DI.	• ¡1ª elección en situaciones URGENTES! • DI: 1,5mg-3mg cada 5' (según situación y antecedentes), hasta Ramsay II-III. • DM: DI x6. • DR: =DI.
LEVOMEPRMAZINA (Sinogan®) • ¡1ª elección: DELIRIUM refractario o si no funciona MDZ! • NEUROLÉPTICO Fenotiazina acción antipsicótica, antiemética y sedante. Sinergia con MDZ. • Vida media: 15-30h.	• 25mg/ml amp 1ml (1amp=25mg)	• DI: 12,5-25mg (sc bolos); 100mg/24h y ↑ según respuesta (sc pc). • DTD: 100mg/día. • DR: 12,5mg. • DMax. (parenteral) 300mg/día.	• DI: 50% sc (bolos, pc).
FENOBARBITAL • BARBITÚRICO acción prolongada. • Vida media 50-150h.	• 200mg/ml	• DI: 100-200mg (bolos im*). 600-800mg/24h y ↑ según respuesta (pc sc). • DR:100mg. DMáx. (media): 1600mg/día.	• DI: 2mg/kg (lentamente) (bolos); y 1mg/kg/h (pc) y ajustar según repuesta.
PROPOFOL • ANESTÉSICO Acción ultracorta. • ¡ÚLTIMA opción! • Inicio acción: 30''. • Vida media: 40-60'	• 10mg/ml	• -----NO-----	• DI: 1-1,5mg/kg en 1-3' (bolos) y 0,5-2mg/kg/h (pc) y ajustar. • DM: 0,5-1mg/kg/h. • DR:50%DI

Principales fármacos empleados en sedación paliativa.

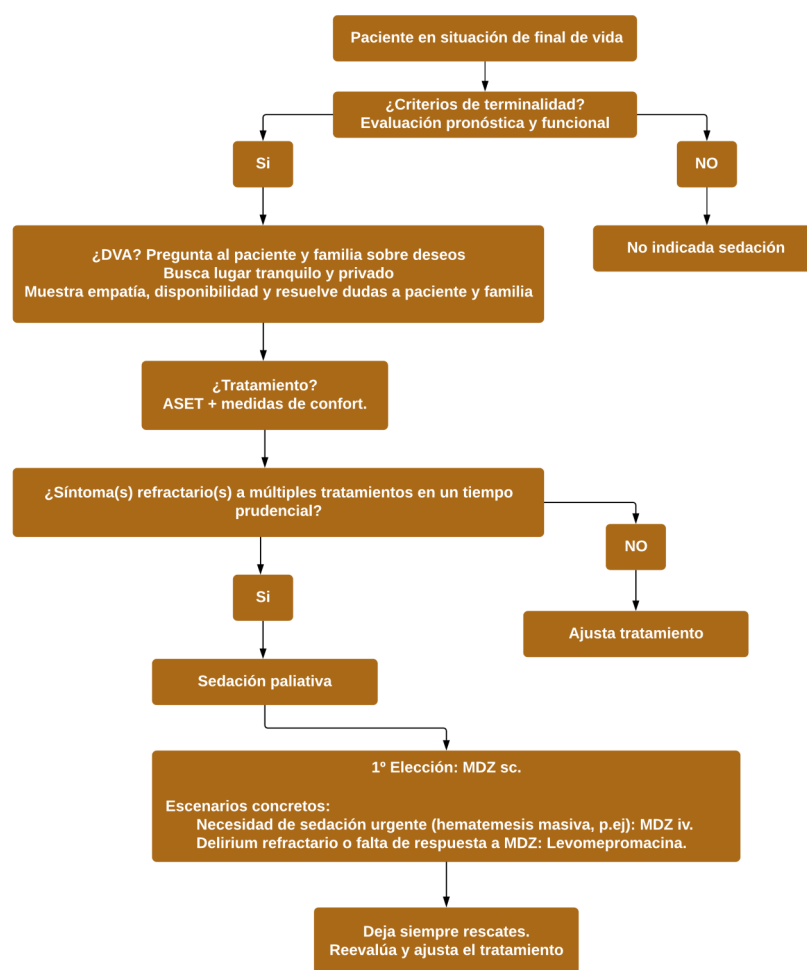
- DI: Dosis de inducción. DTD: Dosis total diaria. DR: Dosis de rescate. DMax: Dosis máxima. DM: Dosis mantenimiento. Pc: perfusión continua. (FENOBARBITAL). *DI es preferible im frente a sc en bolo, por carácter irritativo.

INDICACIONES DE SEDACIÓN EN URGENCIAS:

- Hemorragia masiva: Hemoptisis, hematemesis, otras.
- Refractoriedad al tratamiento (disnea, dolor, delirium).
- Ictus isquémico/hemorrágico masivo/grave/extenso.
- Trastorno ansioso-depresivo, refractario, en relación a conciencia de agonía.
- Agonía.

¡NO TE OLVIDES!

- Sedación paliativa ≠ eutanasia. La primera persigue aliviar un síntoma refractario, mediante la administración proporcionada de fármacos, proporcionando alivio. La segunda busca causar la muerte, mediante una dosis letal de medicación.



ABREVIATURAS

- BD: Broncodilatadores. UPP: Úlcera por presión. FG: Filtrado glomerular. IP: Índice de protrombina. Alb: Albúmina. SHR: Síndrome hepatorenal.

BIBLIOGRAFÍA

- Losada Galván I., Sanz Trepiana L., Azcoitia Álvarez B. Patología general. Principios Básicos en Cuidados Paliativos. En: D. Suarez Pita, J.C.Vargas Romero, J.Salas Jarque, I. Losada

- Galván, B. de Miguel Campo, P.M. Catalán Martín, B. Sánchez Moreno, M.A. Duarte Borges y I. Cabrera Rodrigo, editores. Manual de diagnóstico y terapéutica médica Hospital 12 de Octubre. 8º Ed. España. Acceso online: <https://profesionales.msd.es/login.xhtml>
- Navarro Sanz J. R. Cuidados paliativos no oncológicos: enfermedad terminal y factores pronósticos. [Guía médica en internet] SECPAL. Disponible en: <http://www.secpal.com/CUIDADOS-PALIATIVOS-NO-ONCOLOGICOS-ENFERMEDAD-TERMINAL-Y-FACTORES-PRONOSTICOS>
 - Sánchez Correas M.A., Cuervo Pinna M.A. Protocolo de sedación. Tratamiento farmacológico. [Guía clínica en internet] Sedación paliativa del prcpex, uso y recomendaciones. Disponible en: <http://www.secpal.com///Documentos/Blog/guia-de-sedacion.pdf>
 - Porta Sales J. Sedación paliativa. En: Porta Sales J., Gómez Batiste X., Tuca Rodríguez A. Manual. Control de síntomas en paciente con cáncer avanzado y terminal. 3ªEd. España: Grünenthal pharma S.A. 2013. p. 345-355.